

Branchenvertiefung Heilberufe

Arztpraxen, Apotheken und Heilberufe als Firmenkundensegment

Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sind gefragte Kunden – aber KV-Abrechnung, Goodwill und Praxisübernahme folgen eigenen Regeln. Sie arbeiten die Besonderheiten der Heilberufe durch und rechnen eine Praxisübernahme-Finanzierung vollständig durch. Danach beraten Sie Heilberufler fachkundig und beurteilen Übernahmefinanzierungen sicher.

KOMPETENZFELD
K-02 Branchenwissen

KOMPETENZSTUFE
Sparringspartner

DAUER
ca. 4–4,5 Stunden

VERSION
v1.0

TRANSFER & MATERIALIEN

Der Transferauftrag (Abschnitt Praxistransfer) ist fester Teil des Kompetenzaufbaus – das Beobachtungsformular Ihrer Führungskraft baut auf Ihren Aufzeichnungen auf. Diese Unterlagen samt aller Arbeitsblätter stehen Ihnen dauerhaft digital in der FKB-Campus-Akademie zur Verfügung.

Theorie-Input 1: Freie Berufe – rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

ABGRENZUNG: FREIER BERUF VS. GEWERBE

Die steuerrechtliche Unterscheidung zwischen Freiem Beruf und Gewerbebetrieb ist für den Firmenkundenberater weit mehr als eine juristische Feinheit – sie bestimmt das gesamte wirtschaftliche Erscheinungsbild des Kunden.

Gemäß § 18 Abs. 1 EStG sind Einkünfte aus selbstständiger Arbeit u.a. Einkünfte aus der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Rechtsanwalt, Notar, Patentanwalt, Steuerberater, Architekt, Ingenieur oder ähnlicher Berufe. Das entscheidende Merkmal: Diese Tätigkeit basiert auf persönlicher Berufsqualifikation und wird eigenverantwortlich und fachlich unabhängig ausgeübt (Bundesministerium der Finanzen [BMF], 2023 ^{Q142}).

Die praktischen Konsequenzen für die Bankbeziehung:

Merkmal	Freier Beruf	Gewerbebetrieb
Gewerbesteuer	nein	ja
Buchführungspflicht	nein (EÜR bis 600.000 EUR Umsatz möglich)	ab 800.000 EUR Umsatz
Jahresabschluss	EÜR (Anlage EÜR)	Bilanz + GuV
IHK-Mitgliedschaft	nein	ja (Pflichtmitglied)
Betriebsaufgabe	kein Veräußerungsgewinn bei Praxisübergabe (i.d.R.)	Gewerbesteuer auf Veräußerungsgewinn
Kammerzugehörigkeit	Ärztekammer, Rechtsanwaltskammer etc.	keine Pflichtmitgliedschaft

Quellen: § 18 EStG; § 4 Abs. 3 EStG; Gumpert & Kausch (2022 ^{Q145})

PRAXISRELEVANZ: EINZELPRAXIS, BERUFS AUSÜBUNGSGEMEINSCHAFT (BAG) UND MVZ IM VERGLEICH

Die bloße Abgrenzung „Freier Beruf vs. Gewerbe“ greift in der Beratungspraxis zu kurz. Entscheidend für die Kreditanalyse ist auch die **Organisationsform**, in der der Heilberuf ausgeübt wird:

Merkmal	Einzelpraxis	BAG / Gemeinschaftspraxis	MVZ (GmbH)
Rechtsform	Keine Gesellschaft (Einzelunternehmen)	GbR oder PartGmbH (bei Ärztepartnern)	GmbH (§ 95 SGB V)
Jahresabschluss	EÜR (bis 600.000 EUR Umsatz)	EÜR (bei GbR) oder Bilanz (ab Bilanzierungspflicht)	Handelsrechtliche Bilanz (Pflicht)
Inhaberabhängigkeit	Sehr hoch – Praxiswert an eine Person gebunden	Mittelhoch – Wert verteilt auf Partner; Ausscheiden eines Partners kann den Wert senken	Gering – mehrere angestellte Ärzte

Merkmal	Einzelpraxis	BAG / Gemeinschaftspraxis	MVZ (GmbH)
Haftung	Unbeschränkt persönlich	Bei GbR: gesamtschuldnerisch; bei PartGmbH: berufliche Fehler nur Haftung des handelnden Partners	Gesellschaft haftet; Gesellschafter begrenzt
Kreditrelevanz	Bonitätsanalyse einer Person; DSCR aus persönlicher EÜR	Gesellschaftsvertrag anfordern; Bonitätsanalyse aller Partner; Gewinnverteilung prüfen	Unternehmensfinanzierung; Bilanzkennziffern, Gesellschafterstruktur, DSCR aus GuV
Sicherheitenpool	Persönliches Vermögen des Inhabers	Gemeinschaftliches + privates Vermögen der Partner	Gesellschaftsvermögen + ggf. Gesellschafterbürgschaften

Für den Berater – Daumenregel:

- Einzelpraxis: Standardvorgehen gemäß M07
- BAG mit 2–3 Partnern: immer Gesellschaftsvertrag anfordern, Bonitätsprüfung aller Partner, Regelung bei Ausscheiden eines Partners klären
- MVZ: Spezialisten einbinden (DZ BANK Corporate Finance oder internen gewerblichen Spezialisten) – das ist keine klassische Freiberufler-Finanzierung mehr

Quelle: Gumpert & Kausch (2022 ^{Q145})

EÜR VS. BILANZ: WAS DER BERATER WISSEN MUSS

Die meisten niedergelassenen Ärzte, Zahnärzte und Apotheker erstellen keine handelsrechtliche Bilanz, sondern eine **Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)** nach § 4 Abs. 3 EStG. Dies hat weitreichende Folgen für die Kreditanalyse:

Zufluss-/Abflussprinzip statt Periodisierung: Einnahmen und Ausgaben werden im Jahr ihres Zahlungsflusses erfasst, nicht im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Ein Arzt, der im Dezember eine KV-Abrechnung für das dritte Quartal erhält, verbucht diese erst im Januar des Folgejahres. Die EÜR kann dadurch erhebliche Schwankungen ausweisen, die keine echte Ertragsschwäche signalisieren.

Keine Rückstellungen: In der EÜR werden keine Rückstellungen gebildet. Regressforderungen oder drohende Regresse durch Krankenkassen erscheinen daher nicht in der EÜR – ein wesentlicher Risikoaspekt, den der Berater im Gespräch aktiv erfragen muss.

Keine Abgrenzung von Anlagevermögen in der EÜR: Investitionen erscheinen als sofortiger Aufwand oder werden über AfA-Listen abgeschrieben; eine bilanzielle Kapitalstruktur fehlt.

Für die Schuldendienstfähigkeit gilt:

Hinweis: Bei EÜR-Unterlagen ist die Aufaddierung der Privatsteuern und Entnahmen aus dem Steuerbescheid bzw. der Anlage EÜR erforderlich. Ohne Steuerbescheid ist die Analyse unvollständig (MaRisk BTO 1.2.1 ^{Q030}).

HONORARSTRUKTUREN: KV, PKV UND APOTHEKENMARGE

Kassenärztliche Abrechnung (KV):

Die Vergütung im GKV-System erfolgt über den **Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM)** und ist regional durch Krankenkassen-Kollektivverträge geregelt. Ärzte unterliegen einem **Regelleistungsvolumen (RLV)**, das quartalsbezogen budgetiert ist (Kassenärztliche Bundesvereinigung [KBV], 2024^{Q143}). Die morbiditätsorientierte Gesamtvergütung (MGV) schränkt die Einnahmenseite strukturell ein und macht das GKV-Honorar wenig planbar.

Praxistipp Liquiditätsplanung: KV-Abrechnungen werden quartalsbezogen erstellt und typischerweise **6–10 Wochen nach Quartalsende** ausgezahlt. Das bedeutet: Ein Arzt, der im März (Ende Q1) Leistungen erbracht hat, erhält seine KV-Vergütung erst Mitte Mai. In dieser Lücke müssen Personal, Miete und laufende Ausgaben vorfinanziert werden. Die **Kontokorrentlinie als Dauerlösung** ist daher kein Luxus, sondern strukturelle Notwendigkeit für GKV-Vertragsärzte. Für den Berater: Jeder Neugründer und Praxisübernehmer braucht diese Linie ab Tag 1 – das ist ein konkreter und für Neukunden oft überraschender Beratungsansatz.

Privatärztliche Abrechnung (GOÄ/GOZ):

Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ, Stand: Novellierung 2024) und für Zahnärzte (GOZ 2012) ermöglicht multiplizierte Steigerungssätze (Regelsatz bis 2,3-fach, begründete Erhöhung bis 3,5-fach). Privatpatienten generieren deutlich höhere Deckungsbeiträge.

Heilmittelerbringer (Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden):

Physiotherapeuten rechnen ihre Leistungen nicht direkt über die KV ab, sondern auf Basis von Rezepten (vertragsärztlichen Verordnungen) mit den Krankenkassen. Die Vergütung richtet sich nach den **Heilmittelvereinbarungen** gemäß § 125 SGB V, die zwischen den Leistungserbringerverbänden und den Kassen regional ausgehandelt werden. Für den Firmenkundenberater sind folgende Besonderheiten relevant:

- **Keine KV-Mitgliedschaft:** Physiotherapeuten sind keine Vertragsärzte und haben keine kassenärztliche Zulassung. Sie schließen stattdessen Zulassungsverträge mit den Krankenkassen (Zulassung nach § 124 SGB V). Diese Zulassung ist an Räumlichkeiten und Qualifikationsnachweise geknüpft – nicht personengebunden im selben Sinne wie bei Ärzten.
- **Höheres Liquiditätsrisiko:** Krankenkassen zahlen Heilmittelerbringern regelmäßig erst 4–6 Wochen nach Einreichung der Rezepte. Zudem werden Rezepte bei formalen Fehlern (fehlende Angaben, falsche Diagnose) zurückgewiesen – der Leistungserbringer trägt das Abrechnungsrisiko, wenn der Arzt das Rezept fehlerhaft ausgestellt hat.
- **Deckelung durch Wirtschaftlichkeitsprüfung:** Die Zahl abrechenbarer Behandlungseinheiten pro Patient und Quartal ist durch die Heilmittelrichtlinie begrenzt. Physiotherapeuten können nicht unbegrenzt Leistungen erbringen und abrechnen.
- **Praxisrelevanz Kreditanalyse:** Die Umsatzplanung einer Physiotherapiepraxis ist damit wesentlich von der lokalen Verordnungsmengen-Entwicklung und der Qualität der kooperierenden Arztpraxen abhängig. Keine Arztpraxis in der Nähe = weniger Verordnungen = unsicherere Ertragsbasis.

Praxishinweis: Bei Physiotherapeuten-Finanzierungen immer die letzten 3 Jahre der Krankenkassen-Abrechnungen (Honorarnachweise) anfordern – nicht nur die EÜR. Die Rezeptquote (Anteil GKV/privat) und die Rücklaufquote von Rezepten (Ablehnungsquote) geben Aufschluss über die Qualität der Abrechnungsdokumentation.

Apothekenspezifisch:

Apotheken erzielen Erträge aus dem gesetzlichen Fixzuschlag (aktuell 8,35 EUR/Packung gemäß AMPPreisV), dem prozentualen Zuschlag sowie der Notdienstpauschale. Das AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) beeinflusst über Preisverhandlungen die Erstattungsbeträge von Hochpreispräparaten und wirkt damit auf das Sortiment und die Absatzmenge der Apotheke (ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, 2023^{Q144}). Bei der Kreditanalyse von Apotheken ist das Warenlager (regelmäßig 30–60 Tagesdurchsatzwerte) als wesentlicher Aktivposten zu bewerten.

Theorie-Input 2: Praxisbewertung und Finanzierungsstruktur

PRAXISÜBERNAHME VS. PRAXISGRÜNDUNG

Die Übernahme einer bestehenden Praxis ist die häufigere und aus Bankperspektive komplexere Finanzierungssituation. Entscheidend ist die Bewertungsmethode – denn der zu finanzierende Goodwill muss sich aus dem Ertragspotenzial der Praxis rechtfertigen.

Bewertungsverfahren nach IDW S5:

Der IDW Standard S5 „Grundsätze zur Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie psychotherapeutischen Praxen“ (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland [IDW], 2021^{Q146}) ist der anerkannte Bewertungsstandard für Heilberufe. Er unterscheidet:

Substanzwert: Zeitwert aller materiellen Wirtschaftsgüter (Praxiseinrichtung, Medizintechnik, IT, Vorräte). Dieser Anteil ist relativ unproblematisch zu finanzieren und gut beleihbar.

Ideeller Praxiswert (Goodwill): Der Mehrwert über den Substanzwert hinaus, der durch den Patientenstamm, die Lage, die Praxisorganisation und den Ruf entsteht. Der Goodwill wird als **Ertragswert** berechnet:

Quelle: IDW S5 (2021^{Q146}); Frodl (2019^{Q147})

Substanzwert vs. Buchwert – Kurzklarstellung

Der **Buchwert** ist der steuerliche Restbuchwert eines Wirtschaftsguts nach AfA-Abschreibung (steht in der AfA-Liste der EÜR). Er kann nahe Null sein, auch wenn das Gerät noch voll funktioniert.

Der **Substanzwert (Zeitwert)** ist der tatsächliche Marktwert, den ein Käufer heute für das Wirtschaftsgut zahlen würde – unabhängig vom Buchwert. Beispiel: Ein 5 Jahre altes Röntgengerät hat einen Buchwert von 0 EUR (voll abgeschrieben) – sein Zeitwert für eine übernehmende Praxis beträgt aber vielleicht 8.000 EUR.

Praxisregel: Für den Substanzwert lassen Sie immer einen Sachverständigen schätzen – nicht aus der AfA-Liste ableiten.

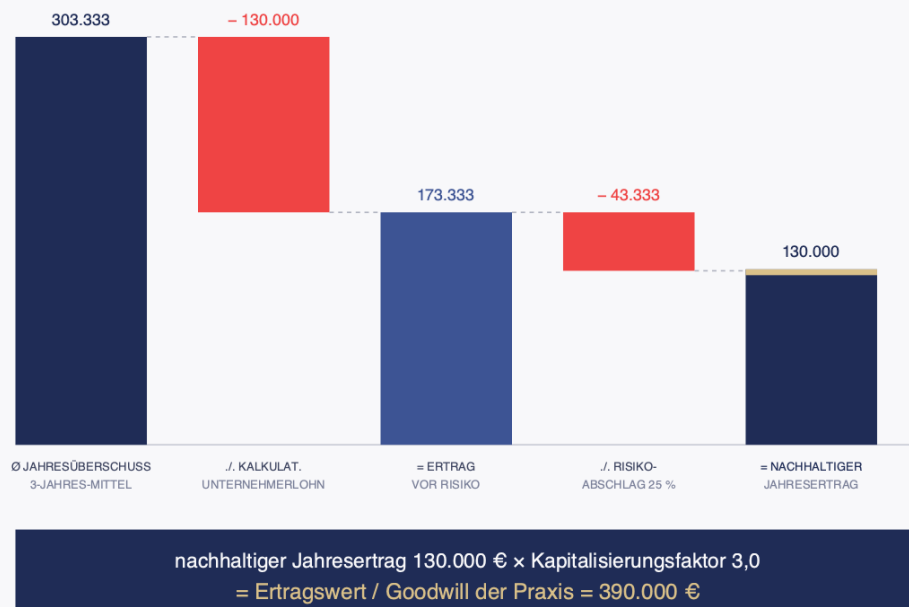
Schnellabschluss-Aufgabe (für TN, die die Goodwill-Basisberechnung bereits fertig haben):

Was ändert sich am Goodwill, wenn der Kapitalisierungsfaktor von 3,0 auf 2,0 sinkt (skeptischeres Gutachten)? Was bedeutet das für die Finanzierungsstruktur? Und ab welchem Kapitalisierungsfaktor entspricht der rechnerische Goodwill genau dem vereinbarten Kaufpreis von 220.000 EUR (vgl. Praxiscase Sec 4.4)?

Lösungshinweis: Bei Faktor 2,0 $\rightarrow 130.000 \times 2,0 = 260.000$ EUR; der vereinbarte Goodwill von 220.000 EUR entspricht rechnerisch einem Faktor von $220.000 / 130.000 \approx 1,7$.

PRAXISWERT-ERMITTLUNG (IDW S5) · MODUL 07 · BRANCHENVERTIEFUNG HEILBERUFE

ERTRAGSWERTVERFAHREN · ZAHNARZTPRAXIS (BEISPIEL) · ALLE WERTE IN €



IDW S5 zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte · § 18 EStG · Ertragswertverfahren für Heilberufspraxen

PRAXISWERT-ERMITTLUNG NACH IDW S5 – SUBSTANZWERT PLUS IDEELLER PRAXISWERT (GOODWILL) NACH MODIFIZIERTER ERTRAGSWERTMETHODE

Bankinterne Bewertung: Für die Kreditsicherung ist der Goodwill nur eingeschränkt beleihbar, da er nicht auf einen Dritten übertragbar ist (persönliche Zulassung). Die Sicherheitenstruktur muss sich daher primär auf andere Positionen stützen (s. Block C).

Praxistipp Praxisübernahme-Strukturierung: Bei Praxisübernahmen mit einer Patientenübernahme-Prognose um 65 % und einem DSCR knapp über der Mindestanforderung: **Tilgungsfreiheit im ersten Jahr beantragen** (nur Zinszahlung). Begründung: Die Patientenübernahme-Quote im ersten Jahr ist erfahrungsgemäß unsicher; ein tilgungsfreies Jahr schafft Liquiditätspuffer, ohne dass dauerhaft auf Kapitaldienst verzichtet wird. Für den Kreditantrag: als risikoadäquate Strukturierungsmaßnahme dokumentieren, nicht als Konzession an den Kunden darstellen. Diese Strukturierung gehört bei jeder Übernahmefinanzierung mit Anlaufisiko in die Kreditvorlage.

TYPISCHE INVESTITIONSANLÄSSE IM ÜBERBLICK

Investitionsanlass	Typisches Volumen	Finanzierungsinstrument	Förderoption
Praxisgründung (Neubau)	200.000–600.000 EUR	Investitionskredit (10–15 J.)	KfW-Unternehmerkredit 037; ERP-Gründerkredit 058/059; L-Bank/LfA
Praxisübernahme (Goodwill + Substanz)	100.000–400.000 EUR	Investitionskredit (7–10 J.)	ERP-Kapital für Gründung 058 (Nachrangdarlehen); KfW 037
Praxisimmobilie (Erwerb/Bau)	300.000–1.500.000 EUR	Annuitätendarlehen; Tilgungsaussetzung	Schwäbisch Hall (Bausparvertrag als Tilgungersatz); KfW Energieeffizienz
Geräteausstattung (CT, MRT-Beteiligung)	50.000–500.000 EUR	Leasing oder Investitionskredit	KfW-Unternehmerkredit 037 ab 25 TEUR
TI-Anbindung/Digitalisierung	10.000–50.000 EUR	Betriebsmittelkredit	KfW-Digitalisierung; L-Bank Digital
Praxissoftware (TIS, DS-Win)	5.000–30.000 EUR	Betriebsmittelkredit	–
Apothekenwarenlager (Erstausrüstung)	150.000–300.000 EUR	Kontokorrent/Betriebsmittel	KfW 037 für Anlauffinanzierung
Filialapotheke (Übernahme)	200.000–500.000 EUR	Investitionskredit	KfW-Unternehmerkredit 037

Förder-Grundsatz: Bei Heilberufe-Finanzierungen ab 50.000 EUR immer KfW-Durchleitungskredit prüfen. Die Kombination Hausbankkredit + KfW-Tranche ist in der Praxis der Regelfall – und das zentrale Differenzierungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern. Für Immobilienfinanzierungen gilt: Schwäbisch Hall (Bausparvertrag als Tilgungsaussetzungsmodell) frühzeitig in die Strukturierung einbeziehen.

Medizinische Versorgungszentren (MVZ):

MVZ als GmbH sind nach § 95 SGB V zugelassene Träger, die Ärzte anstellen. Die Finanzierung von MVZ-Anteilen (häufig durch Krankenhäuser oder Investoren) unterscheidet sich wesentlich von der Praxisfinanzierung: Es gelten handelsrechtliche Bilanzierungspflichten, die Ertragslage ist weniger

von einzelnen Inhaberpersonen abhängig, und die regulatorischen Risiken durch zunehmende MVZ-Konsolidierung sind zu berücksichtigen.

Selbsteinschätzung für Berater: MVZ-Finanzierungen sind in der Regel keine klassischen Praxisfinanzierungen mehr – sie sind Unternehmensfinanzierungen mit Bilanzen, Gesellschafterstrukturen und Volumina, die das FK-Standardgeschäft übersteigen. Wer ein MVZ-Thema identifiziert, sollte frühzeitig den **gewerblichen Spezialisten der VR-Bank oder die DZ BANK Corporate Finance** einbinden. Das schärft die eigene Rolle und schützt vor Fehlberatung durch Unterkomplexität.

PRAXISABGABE AUS VERKÄUFERPERSPEKTIVE: DIE UNTERSCHÄTZTE BERATUNGSSCHANCE

Im realen FK-Bestand einer VR-Bank sind ein erheblicher Anteil der Heilberufe-Kunden zwischen 55 und 70 Jahren und damit in der aktiven oder nahenden Übergabephase. Die **Verkäuferperspektive** ist dabei für die Bank eine strategisch ebenso attraktive Situation wie die Käuferfinanzierung – weil beides zusammen kommt.

Typischer Zeitplan einer Praxisabgabe:

Phase	Zeitraum	Beratungsthemen
Frühphase	5–8 Jahre vor Abgabe	Nachfolgeplanung, Praxisbewertung IDW S5, steuerliche Optimierung Betriebsvermögen
Vorbereitungsphase	1–3 Jahre	Käufersuche (KV, Kammern, Praxisbörsen), Kaufpreisverhandlung
Abschlussphase	12–18 Monate	Notarvertrag, Übergangsbegleitung, Kaufpreiszahlung, Anlage des Veräußerungserlöses
Nachphase	0–5 Jahre	Rentenergänzung aus Versorgungswerk + Kapitalanlage

Steuerliche Aspekte (Grundwissen für den Berater):

- Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf einer freiberuflichen Praxis sind steuerpflichtig, unterliegen aber dem **Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG** (bis zu 45.000 EUR ab Vollendung des 55. Lebensjahres, einmalig)
- Alternativ: Ermäßigter Steuersatz nach **§ 34 EStG** (sog. Fünftelregelung oder halber Steuersatz)
- Bei der Analyse: Steuerberater des Kunden einbinden; für den FK-Berater reicht das Grundwissen zur Gesprächsführung

Anlage des Veräußerungserlöses – Union Investment als Verbundpartner:

- Der Kaufpreis einer Praxis (typisch 200.000–600.000 EUR) fließt dem Abgeber als Einmalbetrag zu
- Zusammen mit dem Versorgungswerk ergibt sich oft ein substanzielles Altersvorsorgepolster

- **Union Investment** ist der natürliche Ansprechpartner für die Anlage dieses Erlöses (ETF-Portfolios, Entnahmepläne, Fondsdepots)
- Gesprächseinstieg: „*Haben Sie schon überlegt, wie Sie den Veräußerungserlös strukturieren – ob und wie viel davon in laufende Entnahmen fließen soll?*“

Für den Berater – konkrete Fragen:

- „Wann ist für Sie der ideale Zeitpunkt der Übergabe?“
- „Haben Sie schon einen Nachfolger im Blick – oder suchen Sie noch aktiv?“
- „Kennен Sie den aktuellen Wert Ihrer Praxis? Eine Schätzung nach IDW S5 ist günstiger als oft gedacht.“
- „Was passiert mit Ihrem Praxisgebäude – bleibt das in Ihrem Eigentum und Sie vermieten es an den Nachfolger?“

Theorie-Input 3: Risikoprofil und Sicherheitenkonzept

SPEZIFISCHE RISIKEN BEI HEILBERUFE-KUNDEN

Zulassungsrisiko:

Der wirtschaftliche Wert der Arztpraxis hängt primär an der kassenärztlichen Zulassung. Diese ist personengebunden und erlischt bei Berufsunfähigkeit oder Ruhesetzung. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) kann die Zulassung auch widerrufen (Disziplinarmaßnahmen, strafrechtliche Verurteilungen). Die Bedarfsplanung der KBV begrenzt zudem Neuzulassungen in überversorgten Gebieten (KBV, 2024^{Q143}).

Kassenarztzulassung und ihre Übertragbarkeit in der Nachfolge:

Ein für die Praxisfinanzierung kritischer Punkt, der in der Beratungspraxis häufig unterschätzt wird: Die Kassenarztzulassung selbst ist nicht übertragbar – sie erlischt mit dem Inhaber. Was übertragen werden kann, ist der **Vertragsarztsitz** (§ 103 Abs. 4 SGB V). Bei der Praxisnachfolge muss der Zulassungsausschuss der KV dem Nachfolger die Zulassung für diesen Vertragsarztsitz neu erteilen. In überversorgten Planungsbereichen (Planungsbereich mit Versorgungsgrad > 110 %) kann der Zulassungsausschuss den Vertragsarztsitz ausschreiben – aber auch eine Nachbesetzung ablehnen, wenn die Versorgung auch ohne die Praxis sichergestellt ist (§ 103 Abs. 3a SGB V). Für die Bank bedeutet das: Bei Praxisübernahmen in überversorgten Gebieten ist das Zulassungsrisiko des Käufers zu prüfen – eine noch nicht erteilte Nachfolgezulassung ist ein wesentliches Auszahlungshindernis.

Praxistipp: Bei jeder Praxisübernahme als Standardfrage: „Ist der Vertragsarztsitz bereits auf Sie übergegangen, oder läuft das Nachbesetzungsverfahren noch?“ Auszahlung des Kredits erst nach schriftlicher Bestätigung der KV über die erteilte Zulassung.

Regressrisiko:

Krankenkassen können Regresse für unwirtschaftliche Verordnungen, Abrechnungsauffälligkeiten oder mangelhafte Leistungen geltend machen. Diese Regresse entstehen rückwirkend und können erhebliche Beträge umfassen – ohne dass eine Rückstellung in der EÜR erscheint.

Inhaberabhängigkeit:

Noch stärker als bei KMU-Unternehmen ist der Praxiswert an die Person des Inhabers gebunden. Berufsunfähigkeit, Tod oder ein schwerwiegender Fehler (Kunstfehler mit Reputationsschaden) können den Praxiswert schlagartig eliminieren. Die Krankenhilfe-Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Berufsrechtsschutzversicherung sind daher wesentliche Nebenaspekte in der Gesamtbeziehung.

Versorgungswerk statt gesetzliche Rentenversicherung:

Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und andere Kammerberufe sind Pflichtmitglieder in berufsständischen Versorgungswerken (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI). Dies hat folgende Konsequenz für die Bankbeziehung: Das Altersvorsorgeguthaben im Versorgungswerk ist nicht beleihbar und nicht abtretbar – es fällt als Sicherheit aus. Der tatsächliche verfügbare Sicherheitenpool ist dadurch erheblich enger als bei einem KMU-Unternehmer mit privatem Immobilienvermögen.

Strukturrisiko MVZ-Konsolidierung:

Bundesweit kaufen Krankenhauskonzerne und Private-Equity-Investoren niedergelassene Praxen auf. Dies schwächt tendenziell die Verhandlungsposition und den Ertragswert von Einzelpraxen in bestimmten Fachgebieten (Zahnheilkunde, Augenheilkunde, Radiologie) erheblich (Gumpert & Kausch, 2022^{Q145}).

SICHERHEITENKONZEPT BEI HEILBERUFE-FINANZIERUNGEN

Sicherheit	Bewertung	Besonderheit
Selbstgenutzte Praxisimmobilie	60–70 % des Verkehrswerts (BelWertV)	Günstigste Sicherheit; oft in GmbH oder Gemeinschaftspraxis
Praxiseinrichtung/Medizintechnik	30–40 % des Zeitwerts	Schnelle Entwertung, eingeschränkte Verwertbarkeit
Privates Wohneigentum	60–70 % des Verkehrswerts	Häufig vorhanden, oft belastet
Lebensversicherung/Kapitalanlage	Rückkaufswert	Einfach abtretbar; bei Versorgungswerk nicht möglich
Goodwill/Patientenstamm	nicht beleihbar	Kein anerkannter Sicherheitenwert
Bürgschaft Ehepartner	abhängig von eigenem Einkommen	AGB-rechtlich sorgfältig dokumentieren

§ 18 KWG (Offenlegungspflicht ab 750.000 EUR Kreditbetrag) ist zu beachten. Die gesamtschuldnerische Bonitätsanalyse bei Praxisübernahmen folgt MaRisk BTO 1.2.1^{Q030}.

Wenn Deckungsquote < 80 %: Pragmatische Lücken-Schließungs-Reihenfolge

| Schritt | Instrument | Typische Deckungswirkung |

|-----|-----|-----|

| 1 | Risikolebensversicherung (Pflicht bei Goodwill-Finanzierung) | In Höhe des Kreditbetrags; hebt die Deckung, sobald an die Bank abgetreten |

| 2 | Abtretung KV-Honorarforderungen (stille Zession) | Laufender Cashflow-Schutz; banküblich bei Praxisfinanzierung |

| 3 | Bürgschaft Ehepartner / mitfinanzierende Person | Abhängig vom eigenen Einkommen; AGB-Dokumentation beachten |

| 4 | Restlaufzeitverlängerung / niedrigere Tilgungsrate | Verbessert den DSCR, schließt aber nicht die Sicherheitenlücke direkt |

| 5 | Eigenkapitalaufstockung fordern | Reduziert den Kreditbetrag und damit die Lücke |

Hinweis: Bei Lücken über 30 % des Kreditbetrags gehört eine Kreditkomitee-Vorlage mit expliziter Lückenbegründung dazu – auch wenn der DSCR ausreichend ist. Eine grüne DSCR-Kennzahl ersetzt kein tragfähiges Sicherheitenkonzept.

VERBUNDPARTNER SCHWÄBISCH HALL: PRAXISIMMOBILIEN UND TILGUNGS AUSSETZUNGSMODELL

Bei selbst genutzten Praxisimmobilien ist **Schwäbisch Hall (SHB)** über den genossenschaftlichen Verbund der strategisch wichtigste Finanzierungspartner – und gleichzeitig ein zentrales Kundenbindungsinstrument. Ein Arzt, der sein Praxisgebäude über die Volksbank und SHB finanziert, wechselt die Bankverbindung deutlich seltener.

Das Tilgungsaussetzungsmodell (Vorfinanzierung mit Bausparvertrag):

Schritt	Inhalt
1	Vorauszahlung: VR-Bank gewährt endfälliges Vorfinanzierungsdarlehen (nur Zinsen, keine Tilgung)
2	Gleichzeitig: SHB-Bausparvertrag über gleiche Summe wird bespart (monatliche Sparrate)
3	Nach Zuteilung (typisch 7–12 Jahre): Bauspardarlehen löst das Vorfinanzierungsdarlehen ab
4	Restlaufzeit: Tilgung über Bauspardarlehen (fester Zinssatz, planbare Rate)

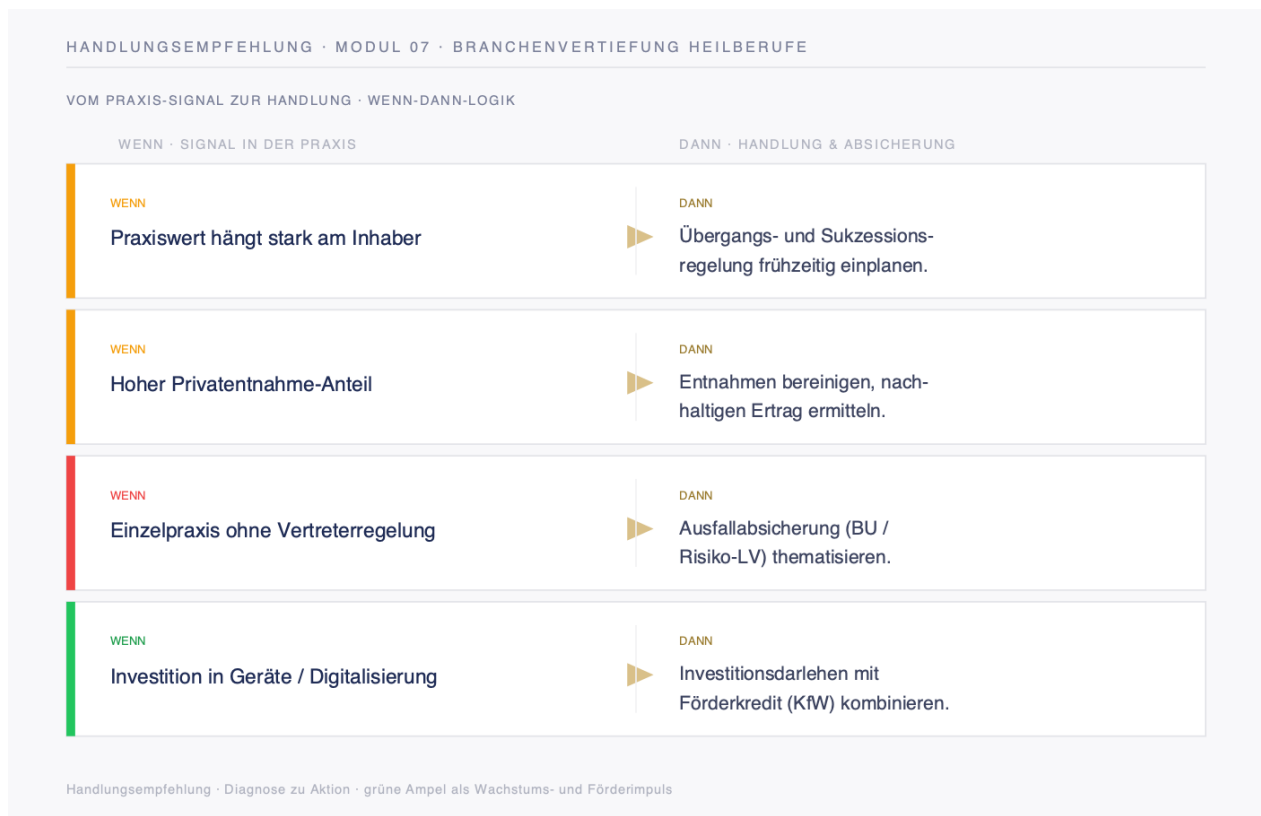
Vorteile für den Kunden:

- Zinssicherheit für die gesamte Finanzierungsdauer (kein Prolongationsrisiko)
- Niedrigere monatliche Belastung in der Ansparphase (nur Zinsen + Sparrate)
- Planbarkeit für einen Selbstständigen ohne festes Gehalt

Für den Berater:

- Schwäbisch Hall frühzeitig einbinden, sobald eine Praxisimmobilie Thema wird
- Kombination KfW-Förderdarlehen + SHB-Bausparvertrag ist ein wettbewerbsstarkes Angebot
- Gesprächseinstieg: „Haben Sie schon darüber nachgedacht, das Praxisgebäude zu besitzen statt zu mieten? Bei Ihrem Einkommensniveau macht das steuerlich und wirtschaftlich oft erheblichen Sinn.“

Die folgende Handlungskarte fasst die zentralen Diagnose-Aktion-Muster für Heilberufe-Kunden zusammen:



HANDLUNGSEMPFEHLUNG HEILBERUFE – WENN-DANN-KARTE: DIAGNOSE-SIGNALE UND PASSENDE BERATUNGSPULSE FÜR FREIBERUFLER-FINANZIERUNGEN

Praxiscase: Dr. Mayer – Zahnarztpraxis-Übernahme in Ravensburg

AUSGANGSSITUATION

Dr. Thomas Mayer (42 Jahre, Zahnarzt, Fachrichtung Allgemeinzahnheilkunde) plant die Übernahme einer gut eingeführten Einzelpraxis in Ravensburg-Stadtmitte. Der bisherige Inhaber (Dr. Schmidt, 67 Jahre) möchte in 18 Monaten in den Ruhestand eintreten und ist bereit, 12 Monate Übergabebegleitung zu leisten.

Kaufpreisverhandlung:

- Substanzwert (Einrichtung, Geräte): 160.000 EUR
- Goodwill (vereinbart, auf Basis IDW S5): 220.000 EUR

- Gesamtkaufpreis: 380.000 EUR

Finanzdaten der Praxis (letzte 3 Jahre, EÜR Dr. Schmidt):

Jahr	Betriebseinnahmen	Betriebsausgaben	Jahresüberschuss
2023	680.000 EUR	390.000 EUR	290.000 EUR
2024	710.000 EUR	400.000 EUR	310.000 EUR
2025	700.000 EUR	390.000 EUR	310.000 EUR

Durchschnittlicher Jahresüberschuss: 303.333 EUR

Finanzierungsbedarf:

- Praxiskauf: 380.000 EUR
- Betriebsmittel (Warenlager, Anlaufkosten): 30.000 EUR
- Modernisierung Röntgenanlage: 25.000 EUR
- Gesamtbedarf: 435.000 EUR
- Eigenkapital Dr. Mayer: 55.000 EUR
- **Kreditbedarf: 380.000 EUR**

Sicherheiten Dr. Mayer:

- ETW Ravensburg (Eigentum), Verkehrswert 290.000 EUR, Grundschuld 120.000 EUR (Restvaluta 85.000 EUR)
- Lebensversicherung (Rückkaufswert 42.000 EUR, abtretbar)
- Praxiseinrichtung (Zeitwert ca. 100.000 EUR nach Übernahme)

AUFGABEN FÜR GRUPPENARBEIT

Aufgabe 1: IDW S5-Plausibilitätsprüfung (Gruppe A)

Prüfen Sie, ob der vereinbarte Goodwill von 220.000 EUR nach der modifizierten Ertragswertmethode nachvollziehbar ist. Gehen Sie von folgenden Annahmen aus:

- Unternehmerlohn: 130.000 EUR p.a. (ortsüblicher Arztgehalt Anstellung)
- Risikoabschlag: 25 %
- Kapitalisierungsfaktor: 3,0 ×

Ist der vereinbarte Goodwill angemessen, zu hoch oder zu niedrig?

Aufgabe 2: Schuldendienstfähigkeit (Gruppe B)

Berechnen Sie den freien Cashflow und den DSCR für Dr. Mayer. Ausgangspunkt ist die Prognos-EÜR Dr. Mayers für das erste Volljahr (65 % Patientenübernahme):

Position	Betrag
Betriebseinnahmen (Prognose Jahr 1, 65 % von Dr. Schmidts Niveau)	455.000 EUR
./. Betriebsausgaben (lfd. Praxiskosten ohne AfA, Prognose)	290.000 EUR
./. Private Einkommensteuer + Soli (Schätzung, Einkommensstufe)	60.000 EUR
./. Privatentnahmen Lebenshaltung	18.000 EUR
./. Laufende ETW-Rate (12.000 EUR/Jahr)	12.000 EUR
= Freier Cashflow vor Kapitaldienst	75.000 EUR p.a.

Hinweis: Die Betriebsausgaben enthalten bereits die laufenden Praxiskosten (Personal, Miete, Material). Steuerbelastung und Entnahmen sind aus dem Steuerbescheid des Vorjahres zu plausibilisieren.

Gegeben:

- Freier Cashflow vor Kapitaldienst: 75.000 EUR p.a.
- Kapitaldienst (380.000 EUR bei 5,5 % Zins, 10 J. Tilgung, linear): ermitteln Sie Jahresrate
- Mindest-DSCR: 1,20

Ist der Kredit unter den gegebenen Bedingungen tragfähig? Reicht ein DSCR von 1,52 bei einem Gründungs- und Anlaufkredit aus?

Schnellabschluss-Aufgabe (für Gruppen, die früher fertig sind): Berechnen Sie den DSCR bei nur 55 % statt 65 % Patientenübernahme. Wie verändert sich der freie Cashflow, und ist die Finanzierung dann noch tragfähig? Welche Strukturierungsmaßnahme würden Sie ableiten?

Lösungshinweis: Bei 55 % sinken die Betriebseinnahmen anteilig auf ca. 385.000 EUR; der freie Cashflow fällt auf rund 55.000 EUR, der DSCR auf ca. 1,11 – also unter die Mindestanforderung von 1,20. Konsequenz: tilgungsfreie Anlaufzeit (siehe Praxistipp Sec 4.2) ist hier nicht Kür, sondern Voraussetzung der Tragfähigkeit.

Aufgabe 3: Sicherheitenkonzept (Gruppe C)

Ermitteln Sie den gesamten Sicherheitenwert auf Basis der vorliegenden Sicherheiten. Welche Deckungsquote ergibt sich zum Kreditbetrag? Welche Lücken bestehen, und wie könnten diese geschlossen werden?

Aufgabe 4: § 18-EStG-Check (Plenum)

Weshalb ist die Abgrenzung „Freier Beruf vs. Gewerbe“ für die Bonitätsanalyse relevant? Nennen Sie drei konkrete Unterschiede mit Auswirkung auf das Kreditengagement.

AB-1: Formelkarte Heilberufe-Finanzierung (Laminat)

Diese Formelkarte fasst die vier Schlüsselformeln des Moduls kompakt zusammen. Sie eignet sich als laminiertes Hilfsmittel für Kreditvorlagen und Kundengespräche.

AB-2: Checkliste Heilberufe-Erstgespräch (15 Punkte)

Nutzen Sie diese Checkliste zur Vorbereitung und Strukturierung von Erstgesprächen mit Heilberufe-Kunden.

Branche & Zulassung

- 1. Zulassungsart: GKV-Zulassung, Privatarzt, MVZ-Anstellung?
- 2. KV-Bezirk und Versorgungsgebiet – übertornt oder Mangelgebiet?

Gesprächsformulierung (bei Praxisübernahme): „Ist der Vertragsarztsitz bereits auf Sie übergegangen, oder läuft das Nachbesetzungsverfahren beim Zulassungsausschuss noch?“

- 3. Berufsbezeichnung und Kammerzugehörigkeit klären
- 4. **Einzelpraxis oder BAG/Gemeinschaftspraxis?** → Bei Berufsausübungsgemeinschaft (BAG): Gesellschaftsvertrag anfordern; Sicherheitenkonzept und Bonitätsprüfung gelten für alle Partner
- 5. **Umsatzsteuer-Status klären** (§ 4 Nr. 14 UStG: Heilbehandlungen grds. USt-frei; Ausnahmen: Gutachtertätigkeit, Schönheitschirurgie ohne Heilzweck → partielle USt-Pflicht möglich)

Einkommenssituation

- 6. Einnahmenquellen: GKV-Anteil / PKV-Anteil / Selbstzahler
- 7. EÜR letzter 3 Jahre + Steuerbescheide anfordern
- 8. Rückstände oder laufende Regressverfahren erfragen

Gesprächsformulierung: „Gibt es derzeit laufende Prüfverfahren der Krankenkassen oder der KV, von denen ich für unsere Unterlagenprüfung wissen sollte? Oder gab es in den letzten drei Jahren Rückforderungen?“ – sachlich, kompetenzzeigend, nicht anklagend.

- 9. Betriebsausgaben auf Plausibilität prüfen (Personalquote, Mietquote)

Investition & Finanzierungszweck

- 10. Gründung, Übernahme oder Modernisierung?
- 11. Bei Übernahme: Bewertungsgutachten nach IDW S5 vorhanden?
- 12. Übergabebegleitung durch Vorinhaber – Laufzeit und Konditionen?

Sicherheiten & Altersvorsorge

- 13. Versorgungswerk: Kammer und Beitragssatz klären

Hinweis: Versorgungswerk-Kapital ist nicht beleihbar und nicht abtretbar (§ 6 SGB VI) – im Sicherheitenkonzept nicht als verfügbare Sicherheit einsetzen.

- 14. Private Immobilien und Belastungen ermitteln
- 15. Lebensversicherungen, Kapitalanlagen (abtretungsfähig?)

Verbund & Nebengeschäft

- 16. **Risikolebensversicherung** (in Höhe des Kreditbetrags, Bezugsrecht Bank) – R+V-Angebot einholen; bei Finanzierungen ab 200.000 EUR Pflichtpunkt in der Beratungsdokumentation
- 17. Berufsunfähigkeitsversicherung vorhanden? (R+V-Angebot prüfen)
- 18. Berufsrechtliche Haftpflicht über R+V/VR-Verbund?
- 19. Praxisimmobilie geplant oder vorhanden? → Schwäbisch Hall Tilgungsaussetzungsmodell prüfen

Reflexionsfragen

- Welche drei Informationen fehlen Ihnen typischerweise beim ersten Gespräch mit einem Heilberufe-Kunden, und wie würden Sie diese strukturiert erfragen?
- Ein Arzt zeigt eine EÜR mit 500.000 EUR Betriebseinnahmen und 350.000 EUR Betriebsausgaben. Was müssen Sie zusätzlich zum Jahresüberschuss wissen, um eine fundierte Kreditentscheidung treffen zu können?
- Wo liegt der wesentliche Unterschied zwischen der Finanzierung einer Zahnarztpraxis und der Finanzierung eines KMU-Betriebs? Was bedeutet das für Ihre Sicherheitenstrategie?

QUELLENANGABEN

- Q³⁰ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]. (2023). Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk BA). In der jeweils aktuellen Fassung.
- Q¹⁴² Bundesministerium der Finanzen [BMF]. (2023). Einkommensteuergesetz (EStG): § 18 Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Bundesministerium der Finanzen. Abgerufen von <https://www.bundesfinanzministerium.de>
- Q¹⁴³ Kassenärztliche Bundesvereinigung [KBV]. (2024). Honorarbericht 2024: Vergütungsstrukturen und Regelleistungsvolumina im GKV-System. KBV.
- Q¹⁴⁴ ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. (2023). Apothekenreport 2023: Wirtschaftliche Situation der deutschen Apotheken. ABDA.
- Q¹⁴⁵ Gumpert, G. & Kausch, M. (2022). Recht der freien Berufe (3. Aufl.). C.H. Beck.
- Q¹⁴⁶ Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland [IDW]. (2021). IDW S5: Grundsätze zur Bewertung von Arzt- und Zahnarztpraxen sowie psychotherapeutischen Praxen. IDW Verlag.
- Q¹⁴⁷ Frodl, A. (2019). Management von Arztpraxen: Kosten senken, Effizienz steigern. Springer Gabler. ## Wissensmanagement & Lernorganisation